만성변비, 제대로 알고 치료하기

진단 기준부터 안전한 약·식사·생활습관까지 — 편안한 배변을 위한 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

만성변비 — 횟수가 아니라 '편하게 다 비우는가'

국제 진단 기준(로마 기준 IV)은 세 가지를 봅니다



1

3개월 넘게 이어집니다

6개월 전에 시작해 최근 3개월 동안 아래 불편이 계속되면 만성변비로 봅니다.

잠깐의 변비는 해당 안 됨



2

네 번에 한 번 이상 불편합니다

배변할 때 **네 번 중 한 번 이상** 힘주기·딱딱한 변·덜 나온 느낌·막힌 느낌·손으로 도와야 함 중 두 가지 이상.

불편 두 가지 이상



3

스스로 보는 횟수가 적습니다

약 없이 저절로 보는 배변이 **주 3회 미만**이면 함께 고려합니다.

주 3회 미만

Tip · 매일 못 봐도 정상일 수 있고, 매일 봐도 변비일 수 있습니다.

근거 · 로마 기준 IV · AGA/ACG 2023 만성변비 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

매일 보지 않아도 건강할 수 있습니다

횟수보다 '편안함'과 '다 비웠는가'가 더 중요합니다

변비가 아닙니다

주 3회 이상, **편하게** 봅니다.

- 매일 가지 않아도 편하면 정상입니다
- 매끈한 소시지 모양(3~4형) 변
- 힘주지 않고 한 번에 나옵니다
- 다 비운 느낌이 듭니다

vs

변비로 봅니다

매일 봐도 **불편하면** 변비입니다.

- 딱딱한 알갱이·덩어리 변(1~2형)
- 오래 힘을 줘야 나옵니다
- 덜 나온 느낌·막힌 느낌이 남습니다
- 치료 목표는 '매일'이 아니라 '편하게 다 비우기'

Tip · 2주 동안 배변 일기(횟수·모양·힘주기)를 써 오시면 진료에 큰 도움이 됩니다.

근거 · 로마 기준 IV · 브리스톨 대변 척도

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

나의 변은 어떤 모양인가요?

브리스톨 대변 척도 — 1형(딱딱)부터 7형(물)까지, 목표는 3~4형

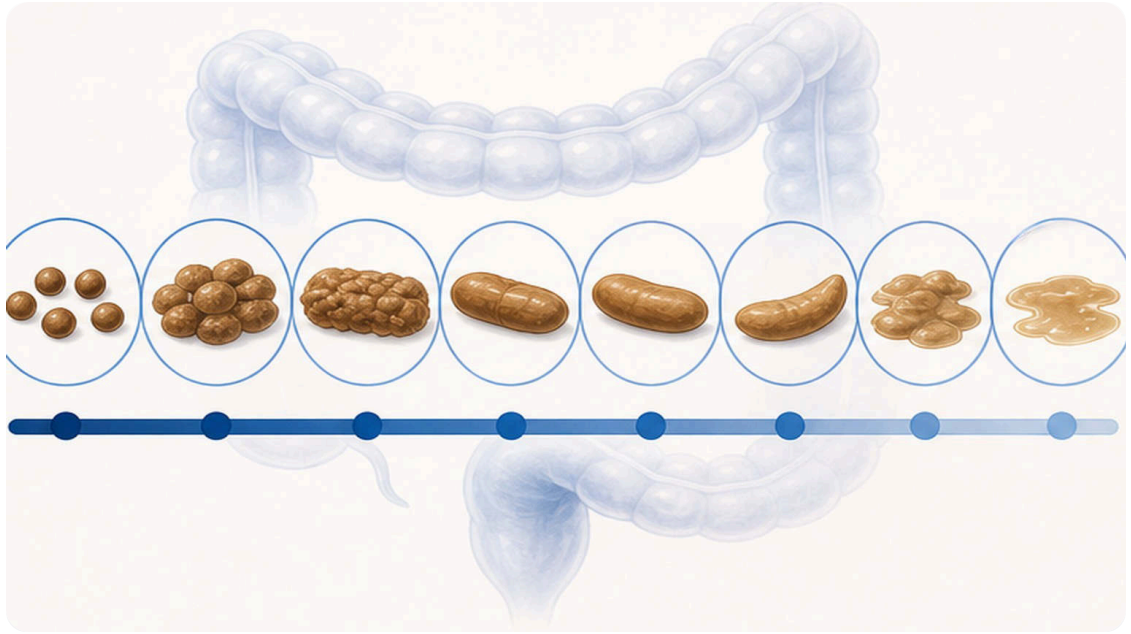


그림 · 왼쪽 딱딱한 알갱이(1형)에서 오른쪽 묽은 변(7형)으로 갈수록 장을 빨리 지나간 변입니다(설명용 그림).

1 **따로 떨어진 딱딱한 알갱이** 1형

심한 변비 — 힘주기·항문 통증·찢어짐이 잦습니다.

2 **울퉁불퉁 단단한 소시지** 2형

변비 — 식사·물 보강과 약이 도움이 됩니다.

3 **매끈한 소시지** 3~4형 · 목표

힘주지 않고 한 번에 나오는 **가장 좋은 변**입니다.

4 **부드러운 덩어리 → 진흙 → 물** 5~7형

설사 쪽 — 7형이 계속되면 탈수 위험이 있어 진료가 필요합니다.

Tip · 변을 보고 몇 형인지 적어 두면 치료 효과를 스스로 확인할 수 있습니다.

근거 · 브리스톨 대변 척도 · Heaton & Lewis 1997

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이런 신호가 있으면 꼭 진료를 받으세요

하나라도 있으면 단순 변비로 넘기지 말고 대장내시경 등 검사가 필요합니다

피가 섞인 변 · 빈혈

변에 피가 섞이거나 대변 잠혈 검사가 양성, 이유를 모르는 철 결핍 빈혈은 대장암의 신호일 수 있습니다.

나도 모르게 빠지는 체중

식사·운동 변화 없이 6개월 안에 체중이 5% 넘게 줄면 종양·대사 질환을 의심합니다.

50세 이후 새로 생긴 변비 · 가족력

중년 이후 처음 생긴 변비, 대장암 가족력, 최근 갑자기 달라진 배변 습관은 대장내시경이 필요합니다.

만져지는 덩어리 · 심한 팽만 · 구토

배나 항문에 덩어리가 만져지거나 배가 심하게 부르고 토하면 장이 막혔을 수 있어 바로 진료받습니다.

Tip · 경고 신호가 없으면 아래의 식사·생활습관·약으로 먼저 치료합니다.

근거 · AGA/ACG 2023 만성변비 지침 · 대한소화기학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

같은 변비라도 유형에 따라 치료가 다릅니다

정확히 나누는 것이 효과적인 치료의 시작입니다

장 운동은 정상 — 가장 흔함

변이 굳어 불편합니다. 배가 아프고 부글거리면 변비형 과민성장증후군입니다. **수용성 섬유질과 PEG**로 대부분 좋아집니다.

장이 느린 유형

며칠씩 변의가 없고 섬유질·일반 변비약이 잘 듣지 않습니다. **장 운동을 돕는 처방약**을 씁니다.

출구가 안 열리는 유형

힘줄 때 항문 주위 근육이 오히려 조입니다. 근육 푸는 법을 다시 익히는 **바이오피드백**이 약보다 낫습니다.

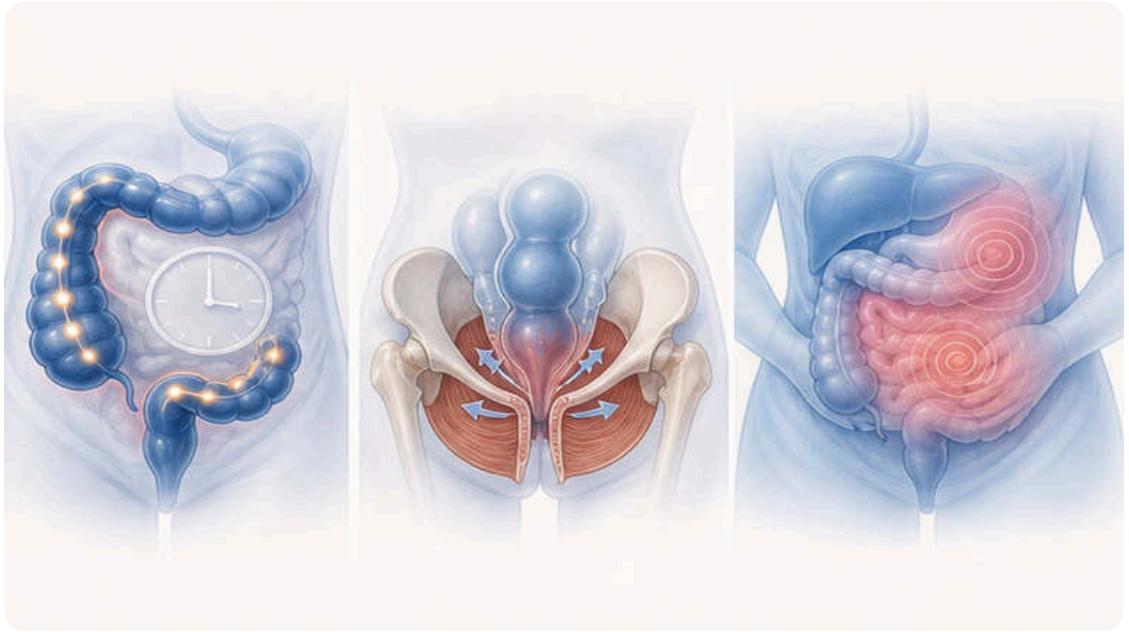


그림 · 느린 장(왼쪽), 출구 근육(가운데), 부글거리는 장(오른쪽) — 원인이 다른 세 가지 변비입니다(설명용 그림).

Tip · 장이 느린 유형은 섬유질만 늘리면 오히려 더 부를 수 있습니다.

근거 · 로마 기준 IV 유형 분류 · ACG 2021

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오래 써도 되는 약과 가끔만 쓰는 약을 나눕니다

모든 변비약이 같지 않습니다 — 언제 먹고 언제 쉬는지는 변비약 안내문을 드립니다(마지막 장 링크)

약	얼마나 써도 되나
PEG(마크로골)	**오래 써도 안전합니다** — 장에 물을 붙잡아 변을 부드럽게 하고, 장을 자극하지 않아 내성·의존이 없습니다
산화마그네슘	효과적이지만 콩팥 기능이 떨어졌거나 나이가 많으면 혈중 마그네슘을 정기적으로 확인합니다
비사코딜(둘코락스)	장을 자극해 밀어내는 약 — 막혔을 때만 쓰는 **구조용**, 4주 이내로
센나·알로에·디톡스 차	'천연' 이름의 자극성 성분 — 오래 쓴 안전성 근거가 부족해 **매일 마시지 않습니다**



그림 · 물에 타 먹는 가루약(PEG), 알약, '천연' 차 — 성분에 따라 쓰는 기간이 다릅니다(설명용 그림).

Tip · 잘 듣지 않으면 장 운동을 돕는 처방약(리나클로타이드·프루칼로프라이드 등)도 지침이 권하는 선택지입니다.

근거 · AGA/ACG 2023 만성변비 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

근거가 있는 식사 — 효과가 확인된 것부터

권하는 음식과 권하지 않는 음식

권합니다

효과가 확인된 것부터 차례로 해 봅니다.

- 그린키위 하루 2개(껍질 벗겨서)
- 차전자피 — 물 200mL 이상과 함께
- 푸룬(말린 자두) 하루 50~100g — 과민성장에는 맞지 않음
- 수용성 섬유질이 많은 채소·과일
- 비피더스 유산균 — 4주 넘게, 보조로

vs

권하지 않습니다

효과가 없거나 오히려 불편해집니다.

- 밀기울 — 가스·더부룩함이 심해질 수 있음
- 이눌린 — 과민성장 변비에서 배가 부름
- 알로에 전잎·숙변 제거 차·다이어트 차
- 변 연화제(도큐세이트) — 효과가 확인 안 됨
- 억지로 물을 많이 마시기 — 근거 부족

Tip · 물은 탈수를 막을 만큼이면 충분합니다 — 억지로 더 마신다고 변비가 낫지는 않습니다.

근거 · 만성변비 생활요법 근거 · 키위 무작위 연구 2021

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

약보다 중요한 생활습관 여섯 가지

배변 습관을 다시 들이면 작은 실천이 큰 변화를 만듭니다

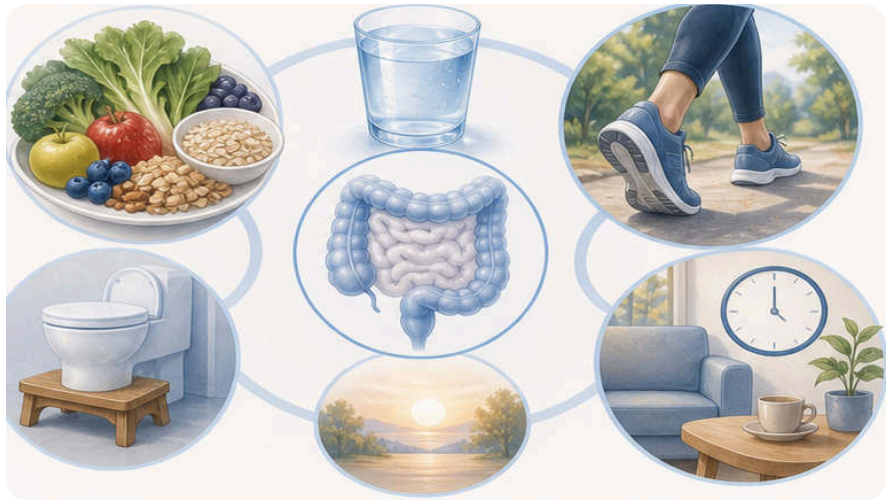


그림 · 먹고, 마시고, 걷고, 정해진 시간에 발판을 딛고 앉는 하루 (설명용 그림).

1. **변의가 오면 참지 않기** 가장 중요
   참기를 되풀이하면 신호를 못 느끼게 됩니다.
2. **식후 15~30분에 앉아 보기** 식후
   밥을 먹으면 장이 움직이는 반사가 가장 강합니다.
3. **같은 시간에 5~10분** 매일
   아침 식사 뒤처럼 시간을 정해 두면 장 리듬이 생깁니다.
4. **하루 30분 걷기** 가벼운 운동
   걷기·요가 정도로 충분합니다.
5. **물은 하루 1.5~2L** 탈수 막기
   더 많이 마신다고 낫지는 않습니다.
6. **발판 딛고 앉기** 선택
   무릎이 올라가 나오는 길이 곧게 펴집니다.

Tip · 변비의 가장 큰 적은 '참는 습관'입니다.

근거 · ACG 2021 생활요법 · 배변 훈련 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

기본 치료로 안 좋아지면 — 단계별로 찾아갑니다

식사·생활습관·일반 변비약으로도 나아지지 않을 때

1

기본 치료 점검

6개월 넘게

식사·습관·변비약에도 계속되면, 먹는 약 중 원인이 있는지 봅니다.

2

항문·직장 검사

전문 검사

항문 근육 압력을 재는 검사와 작은 풍선을 밀어내 보는 검사로 출구 기능을 봅니다.

3

유형 확정

진단

출구형·느린 장·섞인 형 중 어디인지 정합니다.

4

맞춤 치료

치료

출구형은 바이오피드백 4~6회, 느린 장은 장 운동을 돕는 처방약.

최근 시작한 약을 확인하세요 진통제·칼슘제·철분제·혈압약·항우울제가 변비를 일으킬 수 있습니다.

Tip · 새로 생긴 변비라면 최근 바뀐 약부터 진료 때 알려 주세요.

근거 · AGA/ACG 2023 만성변비 지침 · 대한소화기기능성질환·운동학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 꼭 기억할 여덟 가지

변비는 참는 병이 아니라 치료하는 병입니다

01 목표는 '매일'이 아니라 '편하게 다 비우기'

02 PEG(마크로골)는 오래 써도 장을 망가뜨리지 않습니다

03 '천연·디톡스 차'를 매일 마시는 것이 가장 위험합니다

04 변의가 오면 바로 — 참는 것이 가장 큰 적

05 그린키위 2개 + 차전자피 + 적당한 물로 시작

06 '출구가 막힌 느낌'이 계속되면 바이오피드백

07 50세 이후 새 변비·피 섞인 변·체중 감소는 대장내시경

08 2주 배변 일기를 써서 진료 때 함께 봅니다

Tip · 궁금한 점은 진료 때 언제든 물어보세요.

근거 · AGA/ACG 2023 만성변비 지침 · 로마 기준 IV

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 약 사용 카드는 변비약 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

만성변비로 불편한 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 약 선택과 검사는 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

AGA/ACG 2023 만성변비 지침 · ACG 2021 · 로마 기준 IV · 브리스톨 대변 척도 · 대한소화기학회 · 키위 무작위 연구 2021

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요